Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas

Travessa Juca Buchaim, 121 - Bairro: Centro - CEP: 96745000 - Fone: (51) 3658-1087 - Balcão Virtual CAP: 51-99593-5635 - Email: frcharquea1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005459-16.2024.8.21.0156/RS

AUTOR: JACI RAMOS DE VARGAS

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de fornecimento de medicamento ajuizada por **JACI RAMOS DE VARGAS** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, ambos já qualificados. A autora pretende a determinação judicial do fornecimento dos medicamentos **ATEZOLIZUMABE** e **BEVACIZUMABE**, para o tratamento de **NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO - CID 10 C22**. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Requereu tutela provisória para que o réu fosse compelido a fornecer os medicamentos. Ao final, requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária e postulou a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial, a gratuidade judiciária foi indeferida, sendo oportunizado o parcelamento das custas (evento 21, DESPADEC1). A tutela provisória foi deferida, determinando o fornecimento dos fármacos (evento 29, DESPADEC1).

Citado, o réu apresentou contestação (evento 29, DESPADEC1). Discorreu sobre o sistema IPE-SAÚDE e a legislação aplicável, afirmando não incidir o CDC no presente caso. Disse que os medicamentos requeridos pelo autor não possuem previsão legal para sua patologia. Ao final, postulou a improcedência dos pedidos.

Houve réplica (evento 50, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre a produção de provas (evento 52, DESPADEC1), a parte autora manifestou desinteresse e o réu requereu a produção de nova nota técnica (evento 56, PET1 e evento 59, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O presente feito encontra-se apto a julgamento, inexistindo questões preliminares pendentes e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, pelo que possível a imediata análise do mérito.

Com efeito, os serviços fornecidos pela autarquia ré aos servidores estaduais e seus dependentes são submetidos ao regime de direito público, revelando-se imperiosa a observância à Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018, nunca a aplicação da Lei Federal concernente aos seguros privados (Lei n.º 9.656/98).

No caso, o autor é conveniado com o IPERGS, razão pela qual possui direito ao atendimento nos termos do art. 4º da LC n.º 15.145/18, que garante expressamente a assistência médica aos conveniados. Transcreve-se o artigo:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

Por outro lado, o art. 4°, §1°, da LC n.° 15.145/18, exclui da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

> ***Art. 4° [...]***
>
> ***§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.***

Contudo, saliento que, mesmo nos casos em que o medicamento postulado não integre as recomendações técnicas aplicáveis ao plano de saúde, estas não podem se sobrepor à recomendação do médico assistente da parte autora, o qual detém o conhecimento técnico necessário para definir o melhor tratamento ao paciente que acompanha.

O TJ/RS tem consolidado o entendimento de que a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente demanda a apresentação de justificativa técnico-científica do IPE Saúde, não bastando o indeferimento genérico, e que o critério utilizado pela Administração Pública em relação aos serviços do IPE Saúde é o da exclusão expressa, de modo que todos os procedimentos hospitalares e ambulatoriais são custeados, salvo aqueles expressamente excluídos. Veja-se:

> *REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA.* ***IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE.*** *CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. EXEGESE DO § 3º DO ART. 496 DO CPC. Cabível o reexame obrigatório*

quando o valor anual do medicamento/tratamento pleiteado for superior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados e Municípios Capitais, e 100 (cem) salários mínimos para os demais Municípios. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE COBERTURA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO. TRATAMENTO NÃO EXCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO QUE REGE O PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. O ***Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE) funda-se no princípio da exclusão. Vale dizer: apenas os procedimentos expressamente excluídos não estão cobertos pelo sistema. No caso concreto restou evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento do demandante. O fornecimento do fármaco vindicado não encontra vedação expressa na Resolução do plano do IPE-SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA****.(Remessa Necessária Cível, Nº 50446880220208210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 12-01-2023)*

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, ***IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE). PACIENTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID C34.9 (NEOPLASIA DE PULMÃO COM METÁSTASES PULMONARES E MEDIASTINAL).*** *TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. FALECIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Cumpre analisar o mérito da demanda, com fulcro no art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que, embora de regra o óbito superveniente conduza à extinção da ação sem exame de mérito, havendo a concessão de tutela de urgência na origem para o fornecimento do medicamento pleiteado, mostra-se necessária sua eventual confirmação por sentença, em atenção ao disposto pelo art. 296 do CPC.* ***2. Tendo em vista a amplitude de cobertura definida no art. 2º da LC nº 12.134/04, atrelada às disposições da Resolução nº 21/1979, o critério utilizado pela Administração Pública para definição dos serviços oferecidos pelo IPE-Saúde é o da exclusão expressa, de modo que, em princípio, todos os serviços de tratamento hospitalar ou ambulatorial curativos são custeados, exceto os expressamente excluídos. 3. Hipótese em que a patologia em questão tem cobertura, pois inegavelmente inserida na especialidade Oncologia, inexistindo vedação expressa ao seu custeio. Dessa forma, a procedência do pedido é de rigor, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela concedida ainda que no curso processual o autor tenha vindo a óbito.*** *4. A condenação em honorários sucumbenciais decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência. Na hipótese, com a resistência à pretensão da parte autora, a autarquia deu causa ao desdobramento da demanda - princípio da causalidade - provocando a participação do patrono do demandante - que, ao final, sagrou-se vitorioso, com a consequente sucumbência do ente estatal - princípio da sucumbência. 5. Honorários que comportam redução, em apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO IPE-SAÚDE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50009001120218210030, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-11-2021)*

Contudo, incumbia à parte ré a comprovação técnico-científica da ausência de recomendação do tratamento indicado ou que os medicamentos disponibilizados pelo IPE-Saúde constituem alternativa viável ao tratamento, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando a alegação genérica de que o fármaco não integra os protocolos do plano de saúde ou de exclusão da cobertura.

À vista disso, resta evidenciada nos autos a necessidade dos medicamentos pleiteados pelo autor, conforme laudos médicos de evento 1, LAUDO8 e evento 59, ATESTMED2, e, **principalmente, pela Nota Técnica 288194, elaborada pelo Natjus, os quais confirmam que o autor sofre de NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO - CID 10 C22 e necessita fazer uso dos medicamentos ATEZOLIZUMABE 1200 mg e BEVACIZUMABE 15mg/kg:**

Conclusão

Tecnologia: BEVACIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de CARCINOMA HEPATOCELULAR METASTÁTICO.

CONSIDERANDO a solicitação de tratamento em primeira linha.
CONSIDERANDO que a combinação intravenosa de um agente antiangiogênico com um inibidor de checkpoint (bevacizumabe + atezolizumabe) demonstraram pequeno a moderado benefício na sobrevida em comparação com o sorafenibe na primeira linha de tratamento, aumentando as opções terapêuticas para este grupo de pacientes;

CONSIDERANDO que existem dados com benefício de sobrevidal global para a combinação ATEZOLIZUMABE + BEVACIZUMABE;
CONCLUI-SE que HA DADOS técnicos que justiquem o uso de ATEZOLIZUMABE + BEVACIZUMABE no tratamento de primeira linha de carcinoma hepatocelular metastático. Salienta-se que não se configura urgência ou emergência médica, conforme conceito do CFM, no entanto, o tratamento deve ser iniciado com celeridade.

Há evidências científicas? Sim

Dessa maneira, levando em conta o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os laudos médicos atestando a imprescindibilidade do fornecimento dos fármacos requeridos, imperioso o acolhimento do pleito de pedido de medicamento formulado na inicial.

Ainda, ressalto que, em se tratando de fornecimento de medicamento, o segurado não está sujeito à coparticipação, tendo em vista o disposto no artigo 30, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018.

A única ressalva a ser feita é quanto ao fornecimento da medicação pleiteada conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB), conforme determina a Lei n.º 9.787/1999.

De tudo o que foi exposto, tenho que a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **JACI RAMOS DE VARGAS** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** para **CONFIRMAR** a tutela provisória concedida e **CONDENAR** o réu a fornecer à parte autora o tratamento adequado para curar a sua patologia (**NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO - CID 10 C22**), em especial dos medicamentos **ATEZOLIZUMABE** e **BEVACIZUMABE**, conforme as determinações médicas, nas quantidades prescritas, observada a Denominação Comum Brasileira (DCB), nos termos da fundamentação.

Sucumbente, ISENTO o Estado do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei n.º 14.634/2014). CONDENO-O ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei n.º 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular n.º 03/2014- CGJ). Ainda, CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte embargante, os quais arbitro em 10% em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, visto que a tutela buscada pelo autor é a preservação da sua vida e saúde, cujo proveito econômico é inestimável.[1]

Sentença sujeita ao reexame necessário, em atenção ao art. 496 do CPC.

Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos.

Publicada e registrada a sentença, bem como intimadas as partes, automaticamente, via sistema Eproc.

Documento assinado eletronicamente por **FILLIPI HOFFMANN DUTRA, Juiz de Direito**, em 27/10/2025, às 16:39:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093029087v4** e o código CRC **f4426c3f**.

---

1. 1. (PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIRETO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE.1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado Administrativo n. 3).2. O STJ, no julgamento do Tema 106, firmou o entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.3. Não se pode concluir que a exigência da comprovação da hipossuficiência financeira, como requisito para o Poder Público fornecer gratuitamente a medicação prescrita ao autor, leve ao reconhecimento de um estimável proveito econômico.4. A obrigação de fazer imposta ao Estado, em tais casos, dá-se em caráter excepcional, somente se preenchidos todos os critérios estabelecidos no recurso repetitivo, sendo certo que as demandas dessa natureza objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.5. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.881.171/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021) ↩ ↩